



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 25-08-2024 0:26:36

Página 1 de 3

Información Paciente			N° Epicrisis	
Nombre	: Joel Patricio Rojas Aguirre	Rut	: 8.932.824-1	N° Archivo : 2421782
Edad	: 63a 5m 11d	Fecha Nacto:	14/03/1961	Sexo : Masculino
Dirección	: Pto. Williams N 3823	Comuna	: Puente Alto	Teléfono : 9 7484 2020

Información Hospitalización			
Unidad de Ingreso	: Upc - Uci Adulto	Fecha Ingreso	: 10/08/2024 07:26
Unidad de Egreso	: Upc - Uci Adulto	Fecha Egreso	: 25/08/2024 00:08
		Días Estadía: 15	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso
angina

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas
Ecmo Adulto - 20/08/2024 00:00 - Emilio Antonio Flores Araya

Epidemiología

Resumen Clínico
Antecedentes: Mórbidos: Hipertensión Arterial Medicamentos: No Quirúrgicos: Hernioplastía inguinal Alergias: Niega Hábitos: Tabaquismo activo 1-2 cigarros al día últimos 30 años

Historia

Cuadro de 8 horas de síntomas pre coronariografía, con inicio súbito de dolor torácico, retroesternal, opresivo, irradiado a epigastrio, eva 8/10, asociado a sudoración profusa y decaimiento, por lo que consulta en HLF. Se toma EKG que muestra extenso supradesnivel st pared SDST DI, AVL y de V2-6. Se administra aspirina 300mg + clopidogrel 300mg + atorvastatina 80mg + heparina 5000u SC con posterior derivación a SU CASR. Al momento de su ingreso se describe vigil, atento, orientado en TE. Perfusión conservada, RR2T, ventilando sin apremio con FR 17 rpm, Sat 98% ambiental, sin UMA con crépitos bi basales.

EKG a sun ingreso a SU CASR en ritmo sinusal, imagen BCRD, SDST SDST DI, AVL y de V2-6.

Se activó estudio coronariografico de urgencia a las 7:45 en la que se evidencio enfermedad de 3 vasos y oclusión de tercio medio de DA con componente crónico sin poder reperfundir a distal. Posteriormente con persistencia de dolor, estable hemodinamicamente, sin signos de falla cardiaca pero lactico en 29 y troponinas en 103.000. Ecoscopia con lesion de casquete que abarca todos los segmentos apicales determinando una FEVI aprox de 30%. VTI 11 al eco con buen derecho.

En contexto de enfermedad severa de 3 vasos, con IAM SDST agudo sin éxito de perfusión a la coronariografía. Ingresa a pabellón de cardiocirugía para CRM de emergencia a las 14 horas. Ecocardiograma pre CEC evidencia FEVI 15%, sin valvulopatías significativas. Se realiza CRM con 3 PAC, puente aorto-coronario con injerto de vena safena a la arteria descendente anterior, puente aorto-coronario con injerto de vena safena al ramo intermedio, puente aorto-coronario con injerto de vena safena a la rama descendente posterior de la arteria coronaria derecha.

Fecha Última Actualización: 25-08-2024 0:26:36

Página 2 de 3

Se describe en el intraoperatorio líquido pericárdico seroso denso en cantidad moderada, adherencias firmes y laxas hacia aurícula derecha y ambos ventrículos. El corazón está dilatado e hipoquinético global severo. La aorta ascendente mide unos 30 mm es de paredes firmes y engrosadas sin placas calcificadas palpables para la canulación. Las arterias coronarias se ven con mucha dificultad por la pericarditis con múltiples placas muy calcificadas, pero presentan zonas susceptibles de revascularizar, los objetivos de revascularización son de calibre adecuado. Respecto a los conductos la vena safena es de buena calidad, con buen flujo y sin lesiones.

Evoluciona posterior a pabellón con FA con RVR y extrasístoles ventriculares. Asociado a falla biventricular progresiva. Se decide soporte e instalación de BCIA por vía femoral derecha, pero durante la instalación paciente se vuelve hipotenso severo poco respondedor a drogas, por lo que decide escalar a conexión ECMO V-A periférico. Punción bajo ecografía de vena femoral derecha y arteria femoral común izquierda y arteria femoral superficial izquierda para cánula de reperfusión distal de extremidad. Durante canulación con requerimientos de AD + NAD + Milrinona. Que posteriores a inicio de ECMO VA logran titularse a la baja hasta suspender AD y Milrinona, quedando con apoyo de NAD a 0.08 ug/kg/min.

Ecoscopia cardíaca: Contractibilidad globalmente disminuida, VTI 5.5. Se objetiva apertura de válvulas mitral y aórtica.

Diagnósticos Ingreso UCI

Shock cardiogénico

- ECMO VA

- Disfunción VI severa VTI 5.5

IAM c/SDST pared anterior en evolución

Enfermedad coronaria severa de tres vasos ADA proximal ocluida

Pericarditis post IAM

Insuficiencia respiratoria aguda

HTA

Evolución en UCI

Postoperatoriamente, el paciente presentó pericarditis y se conectó a ECMO VA debido a la inestabilidad hemodinámica, que se extendió del 10 al 14 de agosto. La condición del paciente se complicó con un shock hipovolémico y sangrado por drenajes pericárdicos, lo que llevó a un cambio en la configuración del ECMO a VAV el 14 de agosto, y finalmente a ECMO VV el 16 de agosto para soportar la insuficiencia respiratoria y mejorar la oxigenación.

Durante la semana siguiente, el paciente mostró una respuesta clínica variada, con fluctuaciones en los requerimientos de vasopresores y la función renal. El 20 de agosto, el paciente fue decanulado y se retiraron los cables de marcapasos y drenajes pericárdicos. La ventilación mecánica se mantuvo con ajustes continuos debido a la evolución de la insuficiencia respiratoria aguda y la hipoxemia persistente.

El 24 de agosto, el paciente experimentó una desaturación severa con necesidad de aumento de FiO2 hasta el 100%, y la gasometría mostró un PAFI de 88. A pesar de las maniobras de reclutamiento y el ajuste de la ventilación, la oxigenación no mejoró adecuadamente. Se sospechó de tromboembolismo pulmonar (TEP) y se realizó una angiotomografía que descartó TEP en las ramas principales, pero mostró signos de falta de relleno más distal.

Evoluciona con persistencia de hipoxia refractaria y compromiso hemodinámico. A pesar de las maniobras de reclutamiento y el ajuste de la ventilación, el paciente no respondió de manera efectiva. Se permite visita extendida con los familiares, y el paciente falleció a las 00:19 horas, acompañado de familiares. Se emite certificado de defunción

Diagnósticos de Egreso:

1. Shock Mixto (Séptico + Obstrucción de Retorno Venoso):

o Sepsis en evolución, con trombosis de la VCI semioclusiva que contribuye al compromiso hemodinámico y shock.

o Shock cardiogénico persistente a pesar de la revascularización y el soporte con ECMO.

o Shock Hipovolémico con requerimiento transfusional 6UGR, 12U Crioprecipitado, 6U plaquetas

2. Infarto Agudo de Miocardio (IAM) con Septostomía de Pared Anterior:

o Enfermedad severa de tres vasos con oclusión proximal de la ADA.

o Cirugía de Revascularización Miocárdica

o Postoperatorio complejo con pericarditis e insuficiencia cardíaca severa.

3. Insuficiencia Respiratoria Aguda:

o Sepsis pulmonar secundaria con edema pulmonar intersticial y disfunción respiratoria grave.

o Manejo prolongado con ventilación mecánica invasiva (VMI) y soporte con ECMO VV.

4. Infección Nosocomial Asociada a K. pneumoniae BLEE:

5. Ictericia e Insuficiencia Hepática:

Fecha Epicrisis : 25/08/2024 00:26

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 25-08-2024 0:26:36

Página 3 de 3

6. Insuficiencia Renal Aguda (AKI):
o Oliguria persistente con necesidad de diálisis continua venovenosa (CRRT).
7. Trombosis de la Vena Cava Inferior (VCI):
o Semioclusiva, contribuyendo a la disfunción del retorno venoso y shock.

Diagnóstico de Egreso

- Choque, no especificado - 1. Shock Mixto (Séptico + Obstrucción de Retorno Venoso):
o Sepsis en evolución, con trombosis de la VCI semioclusiva que contribuye al compromiso hemodinámico y shock.
- o Shock cardiogénico persistente a pesar de la revascularización y el soporte con ECMO.
- o Shock Hipovolémico con requerimiento transfusional 6UGR, 12U Crioprecipitado, 6U plaquetas
2. Infarto Agudo de Miocardio (IAM) con Septostomía de Pared Anterior:
o Enfermedad severa de tres vasos con oclusión proximal de la ADA.
- o Cirugía de Revascularización Miocárdica
- o Postoperatorio complejo con pericarditis e insuficiencia cardíaca severa.
3. Insuficiencia Respiratoria Aguda:
o Sepsis pulmonar secundaria con edema pulmonar intersticial y disfunción respiratoria grave.
- o Manejo prolongado con ventilación mecánica invasiva (VMI) y soporte con ECMO VV.
4. Infección Nosocomial Asociada a K. pneumoniae BLEE:
5. Ictericia e Insuficiencia Hepática:
6. Insuficiencia Renal Aguda (AKI):
o Oliguria persistente con necesidad

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

fallecido

Plan Post Alta

fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Gonzalo Núñez Muñoz
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 25/08/2024 00:26

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:24

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar